



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 183
Protection maladie



PROGRAMME 183
Protection maladie

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Pierre Pribile

Directeur de la sécurité sociale

Responsable du programme n° 183 : Protection maladie

Les deux actions qui composent le programme « Protection maladie » visent à assurer, en complément des politiques de sécurité sociale, un effort de la solidarité nationale en faveur de l'accès aux soins et de l'indemnisation des publics les plus défavorisés. Qu'il s'agisse de garantir l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière ou de procéder à la juste indemnisation des victimes de l'amiante, les dispositifs existants jouent un rôle central dans la santé des personnes les plus fragiles.

L'aide médicale de l'État (AME) de droit commun assure la prise en charge des frais de santé des personnes étrangères démunies ne pouvant accéder à la protection universelle maladie, car ne remplissant pas les conditions de régularité du séjour. Elle participe pleinement des politiques de santé et de solidarité, avec un triple objectif humanitaire, sanitaire et de maîtrise des dépenses publiques par la lutte contre la fraude.

Le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante contribue au financement de la prise en charge des victimes des conséquences de l'exposition à ce matériau. Elles peuvent ainsi obtenir réparation de leurs préjudices dans un délai rapide et selon une procédure simplifiée.

Cette politique est menée en étroite collaboration avec les partenaires chargés des deux dispositifs rattachés au programme « Protection maladie ». La gestion de l'AME est ainsi déléguée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) tandis que l'indemnisation des victimes de l'amiante est assurée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

Pour mesurer les efforts accomplis, les objectifs et indicateurs de performance sont axés sur l'amélioration des délais d'instruction permettant d'accéder aux droits, ainsi que sur les efforts de contrôle menés par les organismes gestionnaires, notamment pour la vérification des conditions préalables d'ouverture de droits. Ce choix s'explique par la volonté, d'une part, de garantir l'accès à ces dispositifs et aux soins dans les meilleurs délais et, d'autre part, de mettre en œuvre une gestion rigoureuse des politiques engagées, grâce à des actions de contrôle et de lutte contre la fraude.

Afin de fournir au Parlement une vision plus complète de l'efficience des dispositifs, les indicateurs sont enrichis d'éléments permettant de mesurer les efforts accomplis en matière de contrôle, d'efficience de gestion et de régulation des dépenses, ainsi que de données sur les bénéficiaires, leur consommation de soins et l'impact global de ces dispositifs.

Concernant l'AME, le délai moyen d'instruction des dossiers de demande d'AME s'établit à 20 jours sur l'ensemble de l'année 2024 contre 24 jours l'année précédente. Ce résultat confirme l'amélioration des délais d'instruction amorcée depuis 2023, et qui a été renforcée par la mise en place d'automates allégeant les tâches de saisie des agents instructeurs.

Le deuxième indicateur du programme porte sur les actions de contrôle menées sur les dossiers d'AME. Il a été recentré depuis 2018 sur les contrôles effectués par les services de l'agent comptable, en prenant en compte à la fois le volume de contrôles le plus élevé et les actions ciblées sur le principal « risque » du dispositif que constituerait une attribution à tort des droits. Ainsi, un échantillon significatif de dossiers déjà instruits est soumis

à un contrôle aléatoire et approfondi des services de l'agent comptable, portant sur l'ensemble des conditions d'octroi de l'AME. En 2024, le taux de dossiers contrôlés s'établit à 15,5 %. D'autres actions de contrôle des bénéficiaires de l'AME sont également menées. Elles ne relèvent pas de l'indicateur mais sont néanmoins détaillées dans le cadre de ce rapport annuel.

En ce qui concerne le FIVA, le nombre global de demandes d'indemnisation a connu un fort rebond par rapport à 2023 (19 147 demandes enregistrées en 2024 contre 17 418 l'année précédente, soit une hausse de 10 %). Le nombre de nouvelles indemnisations suit une tendance similaire. En effet, avec 2 916 nouveaux dossiers enregistrés en 2024, la progression est de 10 % par rapport aux 2 652 unités de 2023.

Les dépenses d'indemnisation s'élèvent à 377 M €, soit 41 M € de plus qu'en 2023 (+12 %). Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs cumulatifs : la hausse de la demande, ainsi que du nombre de rentes actives (+12 % en 2024 après une hausse déjà constatée de +32 % en 2023, conséquence du revirement de la Cour de cassation sur la nature de la rente attribuée par la sécurité sociale que le FIVA ne peut plus déduire de celle qu'il verse), la revalorisation de 4,6 % de la valeur de la rente au 1^{er} avril 2024, celle du barème d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de 10,5 % pour les dossiers reçus à compter du 1^{er} octobre 2023 qui joue à plein en 2024 et à laquelle s'ajoute une indexation de 4,6 % au 1^{er} avril 2024..

L'activité de production a suivi une évolution comparable à celle des demandes d'indemnisation reçues avec 17 349 décisions envoyées en 2024 contre 16 886 en 2023, soit une hausse de +2,8 %. Le délai moyen de décision est très nettement en deçà du délai légal de 6 mois.

Le traitement totalement dématérialisé des acceptations par les bénéficiaires des offres d'indemnisation a permis de maintenir le délai moyen de paiement à un très bon niveau (1 mois et 2 semaines sur l'année) qui respecte largement le délai réglementaire de 2 mois.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

INDICATEUR 1.1 : Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

INDICATEUR 1.2 : Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

OBJECTIF 2 : Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

INDICATEUR 2.1 : Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

INDICATEUR 2.2 : Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

INDICATEUR

1.1 – Délai moyen d'instruction des demandes d'AME

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Délai moyen d'instruction des dossiers	jours	28	24	24	20	cible atteinte	24

Commentaires techniques

Source des données : Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).
Mode de calcul : moyenne des délais enregistrés par les pôles centralisateurs de l'instruction des demandes d'AME en métropole, et par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d'outre-mer.
Le délai moyen d'instruction des dossiers correspond à celui qui s'écoule entre la date de réception du dossier complet par la CPAM ou CGSS et la date de notification par courrier de la décision d'attribution ou de refus.

ANALYSE DES RÉSULTATS

En 2024, 380 813 demandes d'AME ont été traitées par les caisses d'assurance maladie, soit un volume stable par rapport à 2023.

Le délai moyen d'instruction des dossiers de demande d'AME s'établit à 20 jours sur l'ensemble de l'année 2024, dépassant la cible fixée à 24 jours. Ce résultat confirme l'amélioration des délais d'instruction amorcée depuis 2023, et qui a été renforcée par la mise en place d'automates, allégeant les tâches de saisie des agents instructeurs.

INDICATEUR

1.2 – Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Pourcentage des dossiers d'AME contrôlés	%	15,3	15,4	14	15,5	cible atteinte	14,5

Commentaires techniques

Source des données : CNAM

Mode de calcul :

L'indicateur mesure le pourcentage de dossiers de demande d'AME attribués et renouvelés ayant fait l'objet d'un contrôle aléatoire approfondi par l'agent comptable (justification de l'identité, des ressources déclarées, de la stabilité et de la régularité de la résidence), rapporté au nombre total de dossiers de demande d'AME attribués et renouvelés.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le dispositif de l'aide médicale de l'État (AME) est attribué sous triple condition : le demandeur doit être en mesure de justifier à la fois de son identité, de trois mois de séjour irrégulier en France et de ressources inférieures au plafond de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Son attribution fait l'objet de contrôles renforcés, notamment lors de l'instruction des demandes.

Ainsi, les services de l'agent comptable de la CNAM effectuent des contrôles sur un échantillon représentatif des dossiers de demandes d'AME, selon un plan de contrôle visant à vérifier l'existence et la conformité des pièces justificatives, le respect des conditions d'attribution du droit et de qualité de l'enregistrement dans le système d'information. Cet indicateur de contrôle mesure la part de ces dossiers soumis à cette double instruction, ainsi ciblé sur le risque principal du dispositif que constituerait une attribution à tort des droits AME.

Grâce à la centralisation de l'instruction des demandes d'AME en métropole, les contrôles ont pu être renforcés depuis 2020, avec la hausse du taux de dossiers contrôlés (auparavant fixé à 10 %), et la mise en œuvre systématique de ces contrôles *a priori*, afin de réduire fortement les montants des indus.

En 2024, la cible de 14 % a été dépassée puisque le taux de dossiers contrôlés s'établit à 15,5 %. 49 693 dossiers donnant lieu à un accord d'AME ont ainsi fait l'objet d'un contrôle *a priori* et, parmi eux, 1 142 ont présenté une anomalie menant à un rejet du dossier, soit 2,3 % des dossiers contrôlés. Ces dossiers présentant une anomalie n'ayant finalement pas donné lieu à une ouverture de droits à l'AME, le montant des préjudices évités est estimé à 2,8 M€ (hypothèse de calcul : 1 seul bénéficiaire par dossier, dépense moyenne par bénéficiaire de 2 480 € en 2023).

D'autres actions de contrôles sont menées sur l'AME, notamment celles liées aux mesures prises par le Gouvernement en 2020 en vue de renforcer les exigences de contrôle des conditions d'accès à ce droit.

- Les caisses vérifient la présence physique des demandeurs de l'AME qui doivent désormais déposer leur première demande en main propre.
- Pour l'attribution de l'AME, les caisses contrôlent depuis le 1^{er} janvier 2020 la condition de séjour irrégulier de trois mois, alors qu'une condition de résidence stable de trois mois était auparavant appliquée. Cela vise à prévenir les abus potentiels de personnes arrivant sur le territoire munies d'un visa touristique et qui bénéficieraient immédiatement à l'expiration du titre d'une prise en charge des soins par le biais de l'AME. En 2024, environ 30 % des refus d'AME étaient liés au fait que le demandeur était en situation irrégulière depuis moins de 3 mois.
- Ayant accès à l'outil Visabio depuis l'été 2020, les caisses peuvent détecter les dissimulations de visas et vérifier que les demandeurs de l'AME ne disposent pas de ce titre et sont donc bien en situation irrégulière. En 2024, les caisses ont interrogé Visabio 276 525 fois et trouvé un visa dans 1 932 dossiers, soit 0,7 % des cas. Le visa détecté pouvant être en cours ou échu, le contrôle a conduit à un rejet effectif de 64 dossiers d'AME. Il convient de préciser que l'identification d'une situation de régularité ne repose pas exclusivement sur la consultation de Visabio.

Depuis 2021, le service du contrôle médical de l'assurance maladie peut être sollicité pour accorder la prise en charge de certains soins. En effet, le bénéfice de certaines prestations, programmées et non urgentes, est soumis pour les majeurs à une condition d'ancienneté à l'AME, fixée à neuf mois. Dans les cas où un défaut de prise en charge pourrait entraîner, pour le bénéficiaire, des conséquences vitales ou graves et durables, une dérogation à

cette condition est possible après accord du service du contrôle médical de l'assurance maladie. De 2021 à 2024, les caisses ont reçu 32 demandes d'accord préalable. Sur ce total, 23 demandes ont été considérées comme infondées en raison d'une ancienneté à l'AME supérieure à neuf mois ou parce qu'il s'agissait d'une prestation dont la prise en charge n'est pas soumise à cette procédure. Parmi les 9 demandes d'accord préalable qui ont *in fine* été instruites par le service médical, seule une demande a fait l'objet d'un accord de prise en charge.

En outre, les bénéficiaires de l'AME sont inclus dans les programmes nationaux de contrôle de la CNAM, menés *a posteriori* :

- Sur la stabilité de la résidence, le programme national de contrôle contentieux de la protection universelle maladie (PUMa) lancé en 2019 concerne l'ensemble des assurés et les bénéficiaires de l'AME. Les dossiers à étudier dans le cadre de ce programme sont issus d'une sélection sur la base d'une requête « multi-hébergeurs », de l'exploitation des signalements externes (CAF, Pôle emploi, DGFIP, consulats) et internes (centre national des soins à l'étranger). Les dossiers sont également issus des échanges avec les consulats.
- S'agissant de la consommation de soins, les bénéficiaires de l'AME sont inclus dans le programme « méga-consommant », qui consiste à contrôler les assurés qui demandent le remboursement de quantités importantes de médicaments ou de dispositifs médicaux. Ce programme est mis en œuvre en parallèle de contrôles effectués auprès des professionnels de santé pour déceler les fraudes lors des prescriptions ou facturations, notamment pour des traitements de substitution aux opiacés. Il importe en effet d'articuler ces deux types de contrôles car la mise en évidence lors des investigations d'un réseau se livrant à un trafic implique potentiellement des assurés mais également le prescripteur et celui qui délivre les médicaments.

Dans ce cadre, selon les dernières données disponibles, 120 dossiers relatifs à l'AME ont fait l'objet d'investigations en 2024. Le montant de préjudice s'élève à 0,91 M€ (0,33 M€ de préjudice subi et 0,58 M€ de préjudice évité) contre 0,84 M€ de préjudice en 2023.

OBJECTIF

2 – Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA

INDICATEUR

2.1 – Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de 6 mois	%	71	67	88	87	amélioration	80

Commentaires techniques

Source des données : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

Mode de calcul : suivi mensuel de l'évolution des délais moyens des offres d'indemnisation en mois.

Les offres « présentées » correspondent aux demandes transmises au FIVA, traitées par le juriste responsable du dossier, validées en pré-visa par l'agence comptable et envoyées à la victime.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Si le délai légal de 6 mois porte sur l’ensemble des dossiers, le présent indicateur se concentre sur les victimes de pathologies lourdes, en cohérence avec la priorité fixée dans les contrats d’objectifs et de performance réussis.

La crise sanitaire liée au Covid-19 avait eu un fort impact sur l’activité du fonds pour les exercices récents, avec un recul de cet indicateur au cours de la période 2020-2022 (71 % en 2022 contre 77 % en 2019).

Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu en janvier 2023, la rente versée par la sécurité sociale est assimilée à l’indemnisation d’un préjudice exclusivement patrimonial et non plus de nature mixte (patrimonial et extrapatrimonial). Ce revirement ne permet plus au FIVA de déduire la rente qu’il verse au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent de celle attribuée par la sécurité sociale, sauf dans certains cas assez marginaux tels que la perception par la victime d’une pension militaire d’invalidité.

Cet indicateur a toujours été très dépendant des délais inhérents à la reconnaissance en maladie professionnelle des victimes par les organismes de sécurité sociale (OSS). En effet, lorsqu’une procédure de reconnaissance en maladie professionnelle (MP) est en cours au moment de la réception de la demande, ou lorsque la rente servie à ce titre n’a pas encore été notifiée par l’OSS, le délai de décision dépend du temps mis par les OSS pour transmettre au FIVA les documents nécessaires à l’instruction de la demande.

Deux cas se présentent :

- pour une victime atteinte d’une maladie spécifique d’une exposition à l’amiante (plaques pleurales ou mésothéliome), le lien entre la pathologie et l’amiante étant établi par la loi, le FIVA peut, dans l’attente de la réponse des OSS, faire une offre partielle pour les préjudices extrapatrimoniaux autres que l’incapacité fonctionnelle, cette dernière ne pouvant être indemnisée qu’ultérieurement, par une offre complémentaire, après réception de la notification de rente de l’OSS ;
- Dans les autres cas (maladie de la victime non spécifique d’une exposition à l’amiante comme un cancer broncho-pulmonaire), le FIVA n’ayant pas la possibilité de faire d’offre partielle, doit attendre la transmission des pièces par les OSS.

Les victimes exposées dans un cadre professionnel représentant chaque année plus des deux tiers des demandeurs s’adressant au FIVA, ces délais impactent ceux du FIVA.

Le niveau d’atteinte de cet indicateur s’est nettement amélioré en 2024 par rapport à 2023, année durant laquelle le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation a permis de débloquent un nombre important de demandes déjà anciennes, restées jusque-là en attente de réponse des caisses de sécurité sociale, par l’envoi d’offres complémentaires. La progression est, en effet, de 20 points sur un an avec 87 % de décisions présentées dans les 6 mois contre 67 % en 2023.

INDICATEUR

2.2 – Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

(du point de vue de l'utilisateur)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Pourcentage des offres payées aux victimes de pathologies graves dans le délai réglementaire de deux mois	%	92	95	97	98	cible atteinte	90

Commentaires techniques

Source des données : FIVA.

Mode de calcul : suivi mensuel de l'évolution des délais de paiement en mois.

Les offres « payées » correspondent aux offres acceptées par le demandeur, validées par l'agence comptable et versées à la victime.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La mise en œuvre depuis 2020 d'un processus entièrement numérique de prise en charge des acceptations des offres par les victimes, dans le système d'information collaboratif du FIVA (SICOF), a permis de maintenir cet indicateur à un niveau élevé de réalisation. Malgré les conséquences du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en termes de charge d'activité (augmentation significative du nombre de rentes actives à gérer, +12 % en 2024 qui s'ajoutent aux +32 % déjà constatés en 2023), cet indicateur s'est amélioré pour atteindre 98 %, soit 3 points de plus qu'en 2023.

Ce résultat est d'autant plus satisfaisant qu'il convient de rappeler que pour un certain nombre de dossiers, le FIVA reste toujours dépendant de la transmission par la victime des pièces nécessaires au paiement, ce qui est de nature à allonger le délai de paiement.

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Prévision LFI 2024 Consommation 2024		
02 – Aide médicale de l'Etat	1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante	8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000	8 000 000
Total des AE prévues en LFI	1 216 300 000	1 216 300 000	1 216 300 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-49 560 000	-49 560 000	
Total des AE ouvertes	1 166 740 000	1 166 740 000	
Total des AE consommées	1 166 740 000	1 166 740 000	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
	Prévision LFI 2024 Consommation 2024		
02 – Aide médicale de l'Etat	1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante	8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000	8 000 000
Total des CP prévus en LFI	1 216 300 000	1 216 300 000	1 216 300 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP			
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	-49 560 000	-49 560 000	
Total des CP ouverts	1 166 740 000	1 166 740 000	
Total des CP consommés	1 166 740 000	1 166 740 000	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i>				
<i>Consommation 2023</i>				
02 – Aide médicale de l'Etat	-13 955	1 212 300 000 1 146 000 000	1 212 300 000	1 212 300 000 1 145 986 045
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante		8 000 000 7 520 000	8 000 000	8 000 000 7 520 000
Total des AE prévues en LFI	0	1 220 300 000	1 220 300 000	1 220 300 000
Total des AE consommées	-13 955	1 153 520 000		1 153 506 045

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i>				
<i>Consommation 2023</i>				
02 – Aide médicale de l'Etat	-13 896	1 212 300 000 1 146 000 000	1 212 300 000	1 212 300 000 1 145 986 104
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante		8 000 000 7 520 000	8 000 000	8 000 000 7 520 000
Total des CP prévus en LFI	0	1 220 300 000	1 220 300 000	1 220 300 000
Total des CP consommés	-13 896	1 153 520 000		1 153 506 104

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	-13 955	0	0	-13 896	0	0
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	-13 955	0	0	-13 896	0	0
Titre 6 – Dépenses d'intervention	1 153 520 000	1 216 300 000	1 166 740 000	1 153 520 000	1 216 300 000	1 166 740 000
Transferts aux ménages	1 153 520 000	1 216 300 000	1 166 740 000	1 153 520 000	1 216 300 000	1 166 740 000
Total hors FdC et AdP		1 216 300 000			1 216 300 000	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		-49 560 000			-49 560 000	
Total*	1 153 506 045	1 166 740 000	1 166 740 000	1 153 506 104	1 166 740 000	1 166 740 000

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
14/03/2024		440 000		440 000				
Total		440 000		440 000				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						50 000 000		50 000 000
Total						50 000 000		50 000 000

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		440 000		440 000		50 000 000		50 000 000

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l'impôt qui serait dû en l'absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu'elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2024 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu'il tient compte d'aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2024.

Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d'euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.

Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d'euros (« ε »). La portée du total s'avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n'est donc indiqué qu'à titre d'ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (3)

		(en millions d'euros)		
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale		Chiffrage définitif 2023	Chiffrage initial 2024	Chiffrage actualisé 2024
120117	Exonération totale pour les prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à hauteur de 50 % pour les indemnités temporaires Traitements, salaires, pensions et rentes viagères <i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1927 - Dernière modification : 2009 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-8°</i>	494	487	515
120133	Exonération des indemnités versées aux victimes de l'amiante Traitements, salaires, pensions et rentes viagères <i>Bénéficiaires 2022 : 5955 Ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2004 - Dernière modification : 2004 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-33° bis</i>	7	6	8
520401	Déduction de l'actif successoral des rentes ou indemnités versées ou dues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie Mutations à titre gratuit <i>Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Création : 1992 - Dernière modification : 2006 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 775 bis</i>	nc	nc	nc
Coût total des dépenses fiscales		501	493	523

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
02 – Aide médicale de l'Etat		1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000 1 159 180 000		1 208 300 000 1 159 180 000	1 208 300 000 1 159 180 000
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante		8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000		8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000
Total des crédits prévus en LFI *	0	1 216 300 000	1 216 300 000	0	1 216 300 000	1 216 300 000
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		-49 560 000	-49 560 000		-49 560 000	-49 560 000
Total des crédits ouverts	0	1 166 740 000	1 166 740 000	0	1 166 740 000	1 166 740 000
Total des crédits consommés	0	1 166 740 000	1 166 740 000	0	1 166 740 000	1 166 740 000
Crédits ouverts - crédits consommés						

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	1 216 300 000	1 216 300 000	0	1 216 300 000	1 216 300 000
Amendements	0	0	0	0	0	0
LFI	0	1 216 300 000	1 216 300 000	0	1 216 300 000	1 216 300 000

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	66 896 500	66 896 500	0	66 896 500	66 896 500
Surgels	0	33 103 500	33 103 500	0	33 103 500	33 103 500
Dégels	0	-50 000 000	-50 000 000	0	-50 000 000	-50 000 000

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 1 166 740 000	CP ouverts en 2024 * (P1) 1 166 740 000
AE engagées en 2024 (E2) 1 166 740 000	CP consommés en 2024 (P2) 1 166 740 000
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 166 740 000
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 0					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 0	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 1 166 740 000	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) -1 166 740 000
	AE engagées en 2024 (E2) 1 166 740 000	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 0	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 1 166 740 000
					Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 0
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 0
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Justification par action

ACTION

02 – Aide médicale de l'Etat

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Prévision LFI y.c. FdC et AdP						
Réalisation						
02 – Aide médicale de l'Etat		1 208 300 000	1 208 300 000		1 208 300 000	1 208 300 000
		1 159 180 000	1 159 180 000		1 159 180 000	1 159 180 000

1°) L'AME de droit commun :

L'AME de droit commun a été instaurée le 1^{er} janvier 2000 pour assurer la protection de la santé des personnes étrangères démunies, vivant en France en situation irrégulière vis-à-vis du droit au séjour et ne pouvant donc être prises en charge par la protection universelle maladie, en vertu du devoir de solidarité nationale de l'État envers les personnes les plus précaires. Au 30 septembre 2024 (dernières données disponibles), 465 744 personnes en étaient bénéficiaires.

La population des bénéficiaires de l'AME est majoritairement jeune : 68 % des bénéficiaires ont moins de 40 ans (contre 47 % au sein de la population générale française au 1^{er} janvier 2024). Parmi eux, un quart sont des mineurs, et cette part a augmenté de 5 points de pourcentage en dix ans. Il s'agit d'une population majoritairement masculine, les hommes représentant 55 % de l'effectif total. Enfin, 80 % des bénéficiaires de l'AME sont des personnes seules, 8 % sont des foyers constitués de 2 personnes, 5 % de 3 personnes et 7 % de 4 personnes et plus.

Au 31 décembre 2024, les dépenses de l'AME de droit commun s'élèvent à 1 255 M€. Les prestations de ville constituent 26 % des dépenses en 2024, dont 36 % de dépenses de médicaments et dispositifs médicaux, 41 % d'honoraires des médecins généralistes et spécialistes, de chirurgiens-dentistes et d'auxiliaires médicaux, 6 % de frais d'analyse de biologie médicale et 7 % de frais de transports. Les soins en établissements hospitaliers représentent, en 2024, 65 % de la dépense totale engagée par l'assurance maladie.

D'après les données de l'Agence technique de l'information hospitalière (ATIH), en 2023 (dernières données disponibles)[1], les séjours en médecine représentent près de la moitié des séjours des patients AME et portent majoritairement sur des pathologies relevant de l'hépatogastro-entérologie, de la pneumologie, de l'endocrinologie, du diabète et des maladies métaboliques, de la neurologie médicale, ainsi que des affections cardiovasculaires. L'obstétrique représente un quart des séjours hospitaliers et la chirurgie 19 %. Les dialyses représentent 56 % des séances, contre 29 % pour les chimiothérapies et 13 % pour les radiothérapies.

Pour l'année 2024, les méthodes de prévision des dépenses de l'AME concernant les postes « produits de santé » et « autres soins de ville » ont été modifiées afin que ces dernières suivent la méthode de prévision du poste « prestations hospitalières », construite à partir du nombre de bénéficiaires, du taux de consommateurs (effet « volume ») et de la dépense moyenne (effet « prix »). Antérieurement, la prévision des dépenses de l'AME pour ces deux postes était déduite de séries temporelles, réalisées à partir de données de facturation. Ce changement permet d'harmoniser les méthodes d'estimation entre les différents postes, tout en réduisant les marges d'erreur. Ainsi, la prévision pour l'année 2024 a sous-estimé la réalisation des dépenses de l'AME de 14 M€. En tenant compte de la créance constatée fin 2024 au titre de l'AME de droit commun, l'État détenait, au 31 décembre 2024, une dette de 185 M€.

En effet, les dépenses enregistrées par la CNAM en 2024 s'élèvent à 1 255 M€, en hausse de 15 % par rapport à 2023. Cette évolution correspond à :

- +13 % pour les médicaments ;
- +14 % pour les autres soins de villes (y compris actes et consultations externes) ;
- +15 % pour les prestations hospitalières (hors soins externes).

D'une part, la hausse des dépenses s'expliquerait par la poursuite de la progression des effectifs, moins rapide que l'année dernière mais toujours soutenue (6 % entre 2023 et 2024 contre 10 % entre 2022 et 2023). D'autre part, elle résulterait également de la progression du taux de consommateurs. Plus précisément, le nombre de consommateurs a continué d'augmenter (7 % entre 2023 et 2024), de manière plus dynamique que l'évolution des bénéficiaires, entraînant une hausse du taux de consommateurs de 1 point de pourcentage (en moyenne, 69 % en 2024 contre 68 % en 2023).

Il est à noter que certaines inflexions des dépenses d'AME interviennent parfois tardivement dans l'année, et ne peuvent pas être intégrées dans la budgétisation pour l'année suivante ou dans le schéma de fin de gestion. En effet, le montant définitif des dépenses d'AME de droit commun engagées par la CNAM n'est connu qu'en début d'exercice suivant compte tenu des délais de clôture des comptes de l'assurance maladie (en mars de l'année N+1) et ne peut dès lors être intégralement pris en compte au moment de la budgétisation initiale. Cela explique notamment l'écart entre l'exécution et la dépense totale supportée par la CNAM, qui peut donner lieu à l'accroissement de la dette entre l'État et la CNAM ou à sa résorption.

Les données sur les bénéficiaires au 31 décembre 2024 sont quant à elles disponibles au début du mois de mai de l'année suivante.

2°) Les soins urgents, deuxième poste de dépenses du programme :

En poursuivant les mêmes objectifs de solidarité nationale et de santé publique que l'AME, le dispositif des « soins urgents » permet la prise en charge ponctuelle des frais hospitaliers :

- de personnes en situation irrégulière qui ne peuvent bénéficier de l'AME notamment parce qu'elles n'en remplissent pas la condition de résidence ;
- des demandeurs d'asile majeurs pendant le délai de carence de 3 mois avant leur accès à la protection maladie universelle.

Ces soins ont un périmètre restreint. Ils concernent les soins dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé, les soins destinés à éviter la propagation d'une maladie ainsi que les soins des femmes enceintes ou des nouveau-nés, dispensés exclusivement en établissement hospitalier.

La prise en charge de ces soins correspond ainsi aux remboursements de frais de séjour et de séances hospitaliers, qui ne sont pas rattachés à des individus puisque ceux-ci, par définition, ne sont pas affiliés à un dispositif de prise en charge des frais de santé. Il n'est donc pas possible d'effectuer un suivi des personnes bénéficiant de soins dans ce cadre.

Toutefois, cette donnée peut être approchée par le biais du nombre de séjours (hospitalisations et séances^[2]) au titre des « soins urgents » sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) : 15 902 hospitalisations et 11 631 séances ont ainsi été prises en charge en 2023^[3], soit une hausse de 12 % et de 26 % par rapport à 2022.

Ces éléments sont transmis par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) qui fournit également des informations sur les soins consommés et ces patients. Ainsi, en 2023, plus de la moitié de ces séjours (hors séances) concernaient le champ de la médecine et un quart relevait des séjours obstétricaux. En 2023, 74 % des séances concernaient la dialyse et 14 % la chimiothérapie.

L'état de santé des personnes prises en charge apparaît fortement dégradé, comme en témoigne la proportion de séjours sévères (séjours longs présentant certaines complications ou comorbidités associées), qui s'élève à 34 % des séjours en 2023. Ces séjours sévères représentent les trois quarts du volume économique[4] total des séjours pris en charge au titre des soins urgents (hors séances, obstétrique et séjours pour maladies dues à une infection par le VIH). Ainsi, quelle que soit la tranche d'âge, le nombre moyen de journées d'hospitalisation par séjour est plus élevé parmi les patients pris en charge au titre des « soins urgents » que parmi l'ensemble des assurés en population générale (respectivement 8,1 journées et 4,6 journées).

Dans un souci d'efficience de gestion, le traitement des factures de « soins urgents » est centralisé depuis le 11 juin 2018 au sein de deux CNSU (Centres nationaux de traitement des soins urgents) :

- le CNSU de Paris prend en charge le traitement des factures pour l'ensemble des 8 caisses d'Île-de-France ;
- le CNSU de Calais reprend progressivement jusqu'en 2021 l'ensemble des dossiers des autres caisses, y compris dans les DOM.

Ce dispositif fait ainsi l'objet de mesures de contrôle, aux différentes étapes du processus de demande et de facturation.

Un premier niveau de contrôle est ainsi effectué au moment de la demande préalable d'AME. En effet, pour les étrangers en situation irrégulière, il est nécessaire de présenter une décision de refus d'AME afin de s'assurer que le patient n'est pas éligible à cette aide et par conséquent permettre la prise en charge au titre des soins urgents. Dans ce cadre, les caisses appliquent l'ensemble des contrôles prévus lors de l'instruction des demandes d'AME.

Un second niveau de contrôle est effectué au moment de la liquidation des factures de « soins urgents ». Un renforcement de ces contrôles est d'ores et déjà mis en œuvre dans le cadre de la centralisation du traitement de ces factures. Les services de l'agent comptable des CNSU ont mis en place un plan de contrôle des frais remboursés au titre des « soins urgents » sur le périmètre actuel de reprise. Les supervisions a priori de l'ordonnateur et les contrôles du directeur comptable et financier (à la fois ex-ante et ex-post) portent sur la vérification « administrative » de la conformité des paiements, tant sur l'absence de droits autres de la personne, la présence des pièces au dossier, l'absence de paiements multiples ou encore la vérification de l'annulation de la facture de l'hôpital pour les prises en charge aux « soins urgents » refusées. 10 % des dossiers sont ainsi contrôlés, de manière aléatoire ou ciblée sur les plus forts montants.

D'après les dernières données de facturation de 2024 la dépense sur les soins urgents s'élève à 131,8 M€ en hausse de 24,5 M€. Depuis 2004, une dotation forfaitaire de 70 M€ est versée par l'État à la CNAM au titre de ces dépenses. Le taux de couverture de la dépense par la dotation forfaitaire s'établirait ainsi à 53 % (65 % en 2023).

3°) L'AME humanitaire et les autres dépenses de l'AME :

Les crédits consommés correspondent au remboursement direct et ponctuel de prises en charge exceptionnelles décidées par le ministre chargé de l'action sociale en faveur de personnes françaises ou étrangères ne résidant pas en France (AME dite « humanitaire » en application de l'article L. 251-1 code de l'action sociale et des familles) et au remboursement des frais pharmaceutiques et dépenses de soins infirmiers pour les personnes gardées à vue prévu à l'article L. 251-1 code de l'action sociale et des familles (décret d'application n° 2009-1026 du 25 août 2009) ainsi que pour les personnes placées en centres de rétention administrative (article 11 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative).

Les dispositifs relatifs aux frais de santé des personnes gardées à vue et placées en centre de rétention administrative ont représenté une dépense de 592 940 € en 2024, contre 447 887 € en 2023.

Les dépenses relevant de décisions discrétionnaires du Ministre chargé de la sécurité sociale sont quant à elles financées sur le solde restant de l'enveloppe budgétaire, une fois réglées les dépenses précitées. Concernant ces demandes de prise en charge à titre discrétionnaire, la CNAM procède à une étude approfondie des dossiers visant à écarter les demandeurs venus se faire soigner en France sans avoir souscrit d'assurance susceptible de couvrir leurs dépenses de santé et soumet pour décision les dossiers à la DSS.

Deux dossiers ont été pris en charge en 2024, respectant les conditions d'octroi de l'aide, pour un montant total de 79 755,97 €.

[1] Pour 2024, les données seront disponibles à l'automne 2025.

[2] Une séance est une venue dans un établissement de santé réalisée au cours d'une journée, impliquant une fréquentation itérative pour l'un des motifs thérapeutiques suivants : dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, transfusion sanguine, oxygénothérapie hyperbare, aphérèse sanguine. Certains résultats, présentés ici, distinguent les séjours et les séances, afin de ne pas donner un poids trop important aux séances, du fait de leur caractère répétitif, par rapport aux séjours.

[3] Données transmises par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH). Pour 2024, les données seront disponibles à l'automne 2025.

[4] Le volume économique est obtenu en valorisant les séjours selon les tarifs nationaux des GHS en vigueur depuis mars 2023. La valorisation des extrêmes, des suppléments journaliers et des coefficients Ségur et de reprise sont pris en compte dans le calcul du volume économique.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	1 208 300 000	1 159 180 000	1 208 300 000	1 159 180 000
Transferts aux ménages	1 208 300 000	1 159 180 000	1 208 300 000	1 159 180 000
Total	1 208 300 000	1 159 180 000	1 208 300 000	1 159 180 000

ACTION**03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
03 – Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante		8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000		8 000 000 7 560 000	8 000 000 7 560 000

La dotation de l'État au FIVA s'élevait à 8 M € en LFI. Le montant de la réserve de précaution constituée sur cette action étant de 0,44 M€, le montant des crédits disponibles s'est finalement élevé à 7,56 M €.

L'ensemble de ces crédits a été consommé durant l'exercice.

Comptes du FIVA :

<i>En millions d'euros</i> <i>(en droits constatés)</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation
Charges	362	351,2	289	329,14	322,56	389,45	446,04
Charges d'indemnisation	301,1	300,3	233,9	274,4	264,8	335,95	377,4
Provisions	51,6	40,2	45,3	45	48	42,93	57,5
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	8,3	10,5	9,8	9,74	9,76	10,6	11,1
Produits	366	361	350,7	307,9	307,4	308,6	431,4
Dotation branche AT/MP	270	260	260	220	220	220	353
Dotation État	7,8	7,8	7,7	7,7	7,7	7,52	7,56
Reprises sur provisions	49,7	56,1	59,3	45,4	43,4	49,6	41,7
Autres	38,2	37,2	23,7	34,9	36,3	31,5	29,1
Résultat	4,1	9,7	62,2	-21,2	-15,14	-80,9	-14,7
Investissement	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,2
Variation du fonds de roulement	6,4	-6	47,70	-21,9	-10,5	-87,7	1,4
Fonds de roulement	100,9	94,9	142,6	120,9	110,4	22,7	24,1

Lecture du tableau : les charges sont constituées des versements aux victimes directes et aux ayants droit, ainsi que des charges administratives. Les produits sont constitués des dotations respectives de l'État et de la branche AT/MP de la sécurité sociale. Les reprises sur provisions correspondent à des offres émises n'ayant pas été acceptées au cours de l'année précédente.

1. Le montant des charges du FIVA s'élève à 446,04 M € en 2024

Les charges d'indemnisations de l'année 2024 atteignent 377,4 M € (dont 27,8 M € de charges à payer à comptabiliser) contre 335,9 M € l'an dernier (+12,4 %). Ces niveaux exceptionnels sont la conséquence directe de plusieurs facteurs cumulatifs parmi lesquels la hausse inattendue de la demande (+10 %), l'impact de la revalorisation du barème et la progression continue du nombre de rentes attribuées (+12 % sur un an).

En fin de compte, le montant total des charges d'intervention du FIVA (soit les dépenses d'indemnisation additionnées aux frais d'honoraires de médecins et avocats et aux provisions qui correspondent aux offres d'indemnisation réalisées mais non décaissées à la clôture) atteint 434,9 M €.

Les autres charges s'élèvent à 11,1 M € en 2024, en hausse de 4,7 % par rapport à 2023 (10,6 M€).

2. Les encaissements de recettes atteignent 360,6 M € pour des produits évalués à 431,4 M € en 2024

Par amendement à l'article 107 du projet de loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le montant de la contribution de la branche AT/MP au financement du FIVA a été ajusté à 353 M € contre 335 M € inscrits au projet initial et donc au budget du FIVA voté lors du conseil d'administration du 14 novembre 2023.

Le FIVA perçoit également des recettes propres, issues principalement des recours subrogatoires qu'il exerce contre les responsables des dommages indemnisés (en cas de faute inexcusable de l'employeur), pour un montant total de 29,1 M € en 2024 (-7,6 M € par rapport à 2023).

Le résultat comptable d'exploitation s'évalue à la clôture à -14,7 M €, soit moitié moins qu'anticipé par le BR. Cela concourt à l'amélioration du ratio « résultat/produits » qui passe de -26,2 % au 31 décembre 2023 à -3,4 % à fin 2024. L'amélioration du solde des opérations non décaissables (amortissements et provisions) couplée à la réduction du déficit budgétaire (-19,7 M € prévus et -14,8 M€ à la clôture) permet au FIVA de reconstituer sa capacité d'autofinancement (CAF) après trois exercices successifs en forte insuffisance.

Avec un apport de 1,4 M €, le niveau de fonds de roulement (FDR) à fin 2024 s'élève à 24,1 M €, ce qui représente moins d'un mois de charges d'indemnisation (0,77 mois). Pour rappel, cet indicateur s'établissait à 0,81 mois en 2023 et 4,1 mois en 2022.

	Demande d'indemnisation relatives aux préjudices des victimes	Dont demandes supplémentaires de victimes	Demandes des ayants-droits pour leurs préjudices propres	Total des demandes
2014	6 506	1 343	12 604	19 110
2015	6 640	1 427	13 689	20 329
2016	6 554	1 517	13 128	19 682
2017	6 079	1 408	12 698	18 777
2018	6 960	2 404	11 544	18 504
2019	7 505	2 862	12 220	19 725
2020	5 836	2 442	11 187	17 023
2021	6 390	2 682	10 824	17 214
2022	6 441	3 008	11 723	18 164
2023	6 447	3 037	10 971	17 418
2024	7 460	3 653	11 687	19 147

La demande globale augmente par rapport à 2023 (19 147 demandes enregistrées contre 17 418 l'année dernière, soit une hausse de 8,6 %) et revient à un niveau proche de celui de 2019, dernière année avant l'épidémie de Covid. Le nombre de demandes d'indemnisation relatives aux victimes directes en 2024 (7 460 unités, dont 3 653 présentées par des ayants droits pour le compte des victimes directes) est aussi en progression significative sur un an (6 447 demandes avaient été enregistrées l'an dernier dont 3 037 présentés par des ayants droits).

Les demandes d'indemnisation enregistrées en 2024 au titre des préjudices des ayants droits (11 687) ont été plus nombreuses qu'en 2023 (10 971), soit une hausse de 8 % sur un an.

Ces niveaux de demandes sont supérieurs à ceux de la prévision LFI 2024 et reflètent deux mouvements majeurs : d'une part, une hausse de 10 % du nombre de nouveaux dossiers (2 916 en 2024 contre 2 652 en 2023) et, d'autre part, une progression des demandes dites « supplémentaires » (perte de revenus, remboursement des frais funéraires, tierce personne, frais divers, etc.) qui ont augmenté de 22 % sur un an (5 940 en 2024 contre 4 873 en 2023).

Pour tenter d'expliquer la hausse des nouveaux dossiers, l'hypothèse la plus crédible est celle d'un rattrapage d'activité médicale post Covid équivalent à celui observé pour les activités de soins dans le reste du système de santé, en particulier hospitalières, après la baisse constatée suite à la survenue de la pandémie.

S'agissant de la hausse des demandes « supplémentaires », elle est fortement liée à la progression des demandes pour perte de revenus (préjudice économique) qui expliquent à elles seules la moitié de la hausse. Cette croissance trouve une de ses causes dans le revirement de la Cour de cassation redéfinissant la rente versée par la sécurité sociale comme indemnisant un préjudice exclusivement patrimonial, ce qui augmente le revenu de référence du foyer et renforce la possibilité de versement d'un préjudice économique aux ayants droits de la part du FIVA en cas de décès de la victime.

Le nombre de rentes servies a, sous l'effet de la non-déduction induite par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, fortement progressé, passant de 4 512 en 2022 à 5 955 en 2023 (+32 %) puis à 6 688 en 2024 (+12 %).

Le stock des dossiers n'ayant donné lieu à aucune offre à fin 2024 (1 650) reste en-deçà de 2 000 unités. Par ailleurs, au sein de ces dossiers, 712 (43 %) étaient non recevables au 31 décembre 2024, dans l'attente des pièces nécessaires à leur instruction.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	8 000 000	7 560 000	8 000 000	7 560 000
Transferts aux ménages	8 000 000	7 560 000	8 000 000	7 560 000
Total	8 000 000	7 560 000	8 000 000	7 560 000

